

적정성평가 월간보고서 — 총평·서술부 작성 가이드 (표준 문구 라이브러리)

원자료: D:\워너넷자료\보고서\ (2025년 7~12월 8개 병원 + 2026년 7월 6개 병원, PDF 47건 전수 분석 · 2026-07-15)
목적: 수치(점수표·지표현황)는 시스템이 자동 산출하므로, 그 외 사람이 쓰는 서술부(총평·권고·오류점검)의 문단 구성과 표준 문구를 정리해 누구나 같은 품질로 약식 작성할 수 있게 함.
향후 WinCheck+ 월보고서 화면(evalReport.jsp) 자동 총평 생성 및 TBL_EVAL_REPORT_TPL 시드 자료로 활용.

1. 보고서 실물 표준 구성 (HWP 기준)

순서	섹션	내용	작성 주체
1	제목	{병원명} 적정성평가 보고서 ({YYYY}년 {M}월)	자동
2	예상 종합점수 및 결과	산정 전제 + 당월/누적 점수박스 + 총평(4~6문단)	총평 = 수기
3	구조영역 점수	4지표 표(가중치·현황값·표준화·결과) + 지표구간표	자동
4	진료영역 지표별 분석	■지표명 (획득/가중치점) + 분석내용 불릿	수치 자동 + 권고 수기
5	유치도노관 평가표 작성오류	환자별: 평가표 삽입·제거일 ↔ 지시오더·간호기록 대사	수기(점검 결과)
6	욕창 관련 평가표 작성오류	환자별: 단계·크기·처치·영양공급 불일치	수기(점검 결과)
7	배뇨환자 의무기록 작성오류	환자별 + 작성 유의사항	수기(점검 결과)

2. 고정 전제·면책 문구 (모든 보고서 공통 — 그대로 복사)

산정 전제 (점수박스 위):

- 구조영역: 심사평가원 차등제 신고현황({YY}. {Q}분기). 적정성평가 기간 구조영역은 {다음분기}·{그다음분기} 차등제 신고 내역으로 반영되나, {M}월 예상점수 산정을 위하여 {Q}분기 차등제 신고내역으로 산정함
- 진료영역 (환자평가표 {YYYY.MM.DD}일까지 작성분)
- * 작성일 이후 추가 작성여부 및 수정사항에 따라 지표의 점수변화는 있을 수 있음
- * 항정신성 처방률 및 지역사회 복귀율은 전국 기관별, 상병별 처방률과 행안부의 자료로 산출되므로 정확한 점수를 확인할 수 없어 표준화 3점 구간으로 설정함

월중 검토 단서 (총평 말미에 자주 붙음):

- * 특정 기간에 해당되어 검토일 기준({YY.MM.DD}) 평가표 수정 및 추후 작성 여부에 따라 변동가능성 있음.

3. 총평 = 5문단 프레임 (분석 결과 모든 보고서가 이 골격)

P1. 종합점수 선언 (1문장, 필수)

- 적정성평가 예상점수 {7~N}월의 예상 종합점수는 {X}점으로 {N}등급에 해당함.

- 월별 추이 병기형: (7월 74점, 8월 82.3점, 9월 89.4점, ...) — 등락이 크거나 하락 국면일 때 사용
- 전월비 강조형(상승): 전월대비 종합점수 {d}점 상승이 되었으며, {상위등급}과 점수차이는 {gap}점

P2. 구조영역 (1문단, 필수)

상황별 표준 문형:

- **분기결과 확인·변동없음:** 본원의 구조영역 점수는 {YYYY}년 {Q}분기 차등제 결과 {X}점으로 확인되었으며, {다음분기} 차등제 신고분이 합산되어 최종점수가 산정될 예정임.
- **12월(확정):** 구조영역은 {다음해} 1분기 차등제 신고내역을 참고하여 {올해} 4분기 결과와 합산한 결과, 변동 없이 최종 {X}점으로 확인됨.
- **점수 변동 발생:** {지표명}가 {이전값}명에서 {현재값}명으로 변동됨에 따라 표준화 {S}점, 가중치 {W}점({±d}점)으로 {상승/조정}됨을 확인함.
- **경계 경고:** {지표명}가 표준화 {S}점 커트라인에 있어, 인력 변동 및 재원환자수 변동에 따라 지표 점수 하락 가능성이 존재하므로 재원환자수 추이에 맞춘 {인력}관리가 필요함. (예: 의사 1인당 30명 초과 시 표준화 3점·가중치 5.1점 → 종합 -1.7점)
- **마무리 상투구:** 재원 환자 수 추이에 따른 지속적인 관리가 필요함.

P3. 진료영역 총괄 + 개선 시뮬레이션 (1~2문단, 핵심)

- **양호 지표 나열:** 진료영역에서는 {유치도뇨관 환자분율, 욕창관리 관련 지표, ADL 개선 환자분율 및 HbA1c 적정범위율}이 우수하게 관리되고 있음.
- **취약 지표 지목:** 반면, {지표A}과 {지표B}은 상대적으로 낮은 점수가 예상되어 남은 평가기간 동안 중점적인 관리가 필요함.
- **개선 시뮬레이션 (이 보고서의 간판 문형 — 반드시 수치로):**

{지표}은 {N}명 추가 개선 시 표준화 {S}점·가중치 {W}점이 적용되어 종합점수는 약 +{d}점 상승 가능하며, ...

두 지표가 모두 개선될 경우 종합점수는 총 +{합}점 상승하여 최대 {X}점까지 도달할 수 있을 것으로 확인됨.

- **보완 케이스 환산형** (평가표 오류로 누락된 분자): 평가표 작성 누락 및 {항목} 미체크 사례 {N}건을 보완할 경우 {분자}명 ({%})으로 증가하여 표준화 {S}점·가중치 {W}점 확보가 가능함.
- **누적 산정 주의:** 적정성평가는 매월 산출된 대상자를 누적하여 개선율을 산정하므로, 매월 현황값이 표준화 4~5점 구간대로 여유로운 관리가 필요함.

P4. 예측불가·변동 리스크 지표 (1문단, 필수)

- **현황값 예측이 어려운 'DUR 점검률'**은 표준화 5점·가중치 3점, '지역사회복귀율'은 표준화 3점·가중치 3점으로 산정되어 향후 점수 변동 가능성이 있으므로 {말일}까지 지속적인 대상자 관리가 요구됨.
- **항정 리스크:** 항정신성의약품 처방률이 {%}로 {경계값}%에 근접해 있어, 평가기간이 1년으로 확대된 점을 고려할 때 {다음해 6월}까지 처방률이 안정적으로 감소하도록 지속적인 관리가 필요함. PI 수치가 {1.6/0.2}를 초과할 경우 표준화 {S}점·가중치 {W}점으로 환산되어 종합점수에서 약 {d}점 하락할 가능성이 있음.

P5. 신뢰도 점검·의무기록 (1문단, 필수)

- **기본형:** 신뢰도 점검을 통해 확인된 자료로 적정성평가에 반영되므로 유치도뇨관, 피부상태 등 의무기록 작성 시 주의가 필요하며, 의무기록 간에 불일치하는 기록이나 누락되는 기록이 없도록 관리가 필요함.
- **불일치 다수 발견 시:** 의무기록 신뢰도 점검 결과 환자평가표와 의사 지시, 경과기록 및 간호기록 간 {삽입·제거일자, 욕창 단계, 피부문제 처치 및 영양공급 기록} 등이 일치하지 않는 사례가 다수 확인되어 의무기록과 환자평가표의 일치 여부에 대한 점검이 필요함.
- **연말형:** 신뢰도 점검결과는 적정성평가에 반영되므로 {다음해} 2~3월 예정된 신뢰도 점검에 대비하여 의무기록 수정사항을 반영하여야 함.

- 내부 점검체계 권고형(2026): 평가표 작성 전 처방·경과기록·간호기록·환자평가표를 상호 대조하는 내부 점검체계를 운영하여 기록의 신뢰도를 지속적으로 확보하는 것이 필요함.

4. 상황(국면)별 총평 논조 선택

국면	논조·구성	실제 예
1등급 안정 유지	유지 확인 + "남은 기간 하락 방지 모니터링" 중심	강남수 10~12월
등급 경계(±수점)	상위등급까지 점수차 명시 + 개선 시뮬레이션 집중	늘편한 10월("3등급과 0.14점"), 남서울 11월
하락 국면	하락 원인 지표·감소폭 수치 명시 + "재확인 필요" 경고	인천드림 11월(-8.32점), 늘편한 9월("심각한 점수 예상")
상승 국면	전월비 상승 확인 + "커트라인 여유 확보" 권고	강동스마일 8월, 계요 9월
평가 종료월(12월)	확정치 서술 + 신뢰도 점검 대비 + 차년도 항정 관리	전 병원 12월 공통

어투 규칙: 개조식 종결(~함. ~필요함. ~요구됨. ~가능함. ~판단됨. ~확인됨.)이 표준.

(2026 서울대림만 ~합니다 경어체 — 혼용 금지, 병원별 기준 톤 유지)

지표명은 작은따옴표('육상개선환자분율'), 점수 변화는 +3.52점 / -2.4점 , 표준화·가중치 병기.

5. 지표별 단골 권고 문구 (진료영역 분석내용·총평 공용)

지표	표준 권고 문구
유치도뇨관	전월 평가표 상 기재된 삽입일자부터 14일을 초과하지 않도록 관리가 필요하며, 5점 구간은 3% 미만이나 2% 미만으로 관리를 권장함. (2026: 삽입·교체·제거 전 과정 의무기록 작성)
배뇨관리 (신설)	배뇨일지 3일 이상 작성하였으나 '일정하게 짜여진 배뇨훈련' 또는 '방광훈련프로그램' 항목 미체크로 분자 누락 / 배뇨일지 7일 미만 작성 시 '아니오' 체크 후 실제 작성일수 기재(개정 기준) / 배뇨일지에 실시일자·실금 여부·배뇨횟수(량, mL 단위) 필수
항정신성	12개월이 반영되는 항목으로 40%를 초과하지 않도록 관리 필요 + PI 초과 시 하락 시뮬레이션
DUR	예상점수는 100% 가정(가중치 3점). 매월 심사평가원 DUR 점검완료 현황 확인 필요. 확인경로: 영양기관업무포털 → 모니터링 → DUR정보 → 기관별 DUR 점검완료현황
욕창처치	압력을 줄여주는 도구 사용, 체위변경, 영양공급, 드레싱 4가지 모두 수행 시 해당 + 적정칼로리 대비 부족 kcal 지적(예: "적정 1,560kcal 대비 60kcal 부족 → 미충족")
욕창개선	{N}명 추가 개선 시 +{d}점 시뮬레이션 + 주차별 창상 사정·호전 여부를 평가표에 기록(개선 기록 누락으로 낮게 산정되는 경우 다수)
ADL	2023년도 표준화 5점 구간(45%)이 매우 높아져 높은 수준의 현황값이 요구됨 + 상위 등급 목표 시 구간 기준보다 10~20% 여유 관리 권장
HbA1c	적정범위 4.0~8.5%. 평가표 작성 전 재검으로 적정범위 확인 + 한방명세서상 당뇨병 기재 주의(분모 유입)
장기입원	평가기간 중 한 달만이라도 (의료)중도 이상으로 분류되면 분모(대상자)에서 제외되므로 적극적인 환자 사정이 필요함.
지역사회 복귀율	타병원 이송·전원 환자는 진료결과 '이송/회송', 사망은 '사망'으로 체크 필요.

6. 오류점검 섹션(5·6·7) 서술 형식

- **유치도뇨관**: 환자별 차트번호 성명 → 6월 평가표 작성일 / 7월 평가표 작성일 → g-x-1 삽입일자 / g-x-2 제거일자 ↔ 간호 기록·지시오더 확인 내용 대조. 동일 유형은 동일작성자) ... 로 묶음.
- **욕창**: 간호기록지와 평가표 욕창 단계 불일치(G3↔G4), 과거력 (3)확인불가 → (1)있음 수정, 처치·영양공급 기록 누락 보완 필요, 적정칼로리 부족 계산.
- **배뇨**: 평가표 체크 누락·배뇨일지 작성 기준(7일 개정) 통일 안내.
- → **WinCheck+** 크로스체크 화면(유치도뇨관 오류점검·특정수가 대사)이 이 섹션의 전산화 대응물 — 화면 결과를 붙여넣는 방향으로 연계 가능.

7. 약식(웹 월보고서) 총평 자동 생성 템플릿

evalReport.jsp 핵심 진단(diag_core) / 결론(concl1) 에 적용할 수 있는 조립식 골격.

{ } 슬롯은 전부 화면이 이미 가진 값(지표 점수·구간·fiveZone·목표등급)으로 채울 수 있음:

- [P1] 적정성평가 예상 종합점수는 {total}점으로 {현재등급}에 해당함.
- [P2] 구조영역은 {struct}점으로 {안정적인 수준을 유지하고 있으며|일부 지표가 커트라인에 있어 인력 관리가 필요하며}, 실제 점수는 {반영분기} 차등제 신고 결과로 확정되므로 재원환자수 추이에 따른 지속적인 관리가 필요함.
- [P3] 진료영역에서는 {만점지표 나열}이 우수하게 관리되고 있음.
반면 {부족지표1} · {부족지표2}는 상대적으로 낮은 점수가 예상되어 중점 관리가 필요하며,
{부족지표1}은 {n}명 추가 개선 시 표준화 {s}점 · 가중치 {w}점으로 종합점수 +{d}점 상승이 가능함.
- [P4] 현황값 예측이 어려운 'DUR 점검률'(표준화 5점 가정)과 '지역사회복귀율'(표준화 3점 가정)은 최종 결과에 따라 점수 변동 가능성이 있어 지속적인 대상자 관리가 요구됨.
- [P5] 신뢰도 점검 결과는 적정성평가에 반영되므로 의무기록과 환자평가표의 일치 여부 점검이 필요함.

다음 단계(개발 시): 위 P1~P5를 evalReport.jsp의 자동 문구 생성(autoAna 방식)으로 구현하고,

병원별 특이사항만 편집·저장(override)하게 하면 "약식 보고서"가 조회 즉시 완성됨.

8. 2026년(2주기 8차) 변경사항 메모 — 2025 문구 재사용 시 주의

- 유치도뇨관: 가중치 **6점 → 3점**, 산정도 "14일 초과" → **당월 보유 기준**으로 변경
- 배뇨관리 실시 환자분율 신설(가중치 3점) + 배뇨일지 **7일 기준** 예/아니오 개정
- 욕창처치 2→**4점**, 욕창 새로생김 4.4→**4점**, 욕창개선 17.6→**16점**
- 구조영역: 26.3분기로 예상 산정, 실반영은 **2026.4분기·2027.1분기**
- 2025년 문구의 구간·가중치 수치를 그대로 복사하지 말 것 (표준화 구간표는 시스템 값 사용)